



Lampiran : Satu berkas

Hal : Revisi Rekomendasi Hasil Audit Medis TKMKB Tahun 2024
Kasus Pneumonia

Yth.

Direktur/ Kepala FKRTL Mitra BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang
di
Malang Raya

Pertama-tama kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Malang menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan surat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang sebelumnya nomor 5246/VII-05/1124 tanggal 15 November 2024 perihal Rekomendasi Hasil Audit Medis TKMKB Tahun 2024 Kasus Pneumonia dan Ventilator, Bersama ini kami sampaikan Revisi Rekomendasi Hasil Audit Medis TKMKB Tahun 2024 Kasus Pneumonia pada Lampiran Skor Downe yang semula tercantum 1,2,3

Pemeriksaan	Skor Downe		
	1	2	3
Frekuensi Nafas	<60/menit	60-80/menit	>80/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan pemberian O ₂	Sianosis walaupun diberi O ₂
Suara Nafas	Suara nafas di kedua paru baik	Suara nafas di kedua paru menurun	Tidak ada suara nafas di kedua paru
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu

namun seharusnya tercantum 0,1,2.

Pemeriksaan	Skor Downe		
	0	1	2
Frekuensi Nafas	<60/menit	60-80/menit	>80/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan pemberian O ₂	Sianosis walaupun diberi O ₂
Suara Nafas	Suara nafas di kedua paru baik	Suara nafas di kedua paru menurun	Tidak ada suara nafas di kedua paru
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. Raden Tumenggung Suryo 44 Malang

Telp. +62 341 493026

Fax. +62 341 493802

www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang



Roni Kurnia Hadi Permana

Tembusan: Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
AN/de/pk00



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Nomor : 37/TKMKBPUSAT/102024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Audit Medis Tahun 2024
Tema Pneumonia

Jakarta, 21 Oktober 2024

Yth. Direktur Utama
BPJS Kesehatan
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis tema pneumonia yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang maka berdasarkan hasil audit medis terdapat temuan-temuan dan rekomendasi perbaikannya. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini terlampir disampaikan rekomendasi dari TKMKB Pusat.

Semoga rekomendasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk BPJS Kesehatan dan pemangku BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Impelementasi dari rekomendasi ini diharapkan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua TKMKB Tingkat Pusat

(Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H, D.Sc)

Tembusan:

1. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat – BPJS Kesehatan
3. Ketua PB PAPDI
4. Ketua PP PDPI
5. Ketua PP IDAI
6. TKMKB Provinsi di Seluruh Indonesia
7. TKMKB Cabang di Seluruh Indonesia

REKOMENDASI HASIL AUDIT MEDIS
TEMA PNEUMONIA
TKMKB PUSAT

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) telah melakukan audit medis kasus pneumonia pada Tahun 2024. Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil audit medis atas kasus pneumonia sebagai berikut:

I. Temuan Hasil Audit Medis

1. Aspek Medis

- a. Penegakan diagnosis pneumonia belum sesuai PNPK Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023, hanya dari klinis, sebagian belum terbukti dari gambaran radiologi maupun kultur atau pemeriksaan tambahan lainnya. Terdapat kasus yang belum jelas terdiagnosis pneumonia, namun didiagnosis pneumonia (baik sebagai diagnosis utama maupun diagnosis sekunder).
- b. Pada penelusuran RM, terdapat pada beberapa status pasien dirawat bukan karena pneumonia, namun pada resume medis diagnosis utama (DU) nya pneumonia. Terdapat juga pasien yang dirawat untuk operasi kecil, namun terdapat diagnosis pneumonia padahal dikonsulkan ke Sp. PD hanya sebagai toleransi operasi. Selain itu terdapat pasien yang dirawat karena edema paru, CKD overload, anemia gravis dengan tata laksana utama HD, transfusi, intra HD, furosemide, namun DU pulang adalah pneumonia.
- c. Pasien rawat inap dengan diagnosis pneumonia/bronchopneumonia, namun tidak ditemukan adanya pemenuhan kriteria untuk penentuan rawat inap berdasarkan CURB-65 atau PSI sebagaimana dalam PNPK Nomor

HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa.

- d. Standar Prosedur Operasional (SPO) pneumonia dewasa tidak mengacu pada PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa dalam menilai derajat keparahan penyakit pneumonia.
- e. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pneumonia Dewasa tidak dilengkapi dengan pemeriksaan mikrobiologi (gram/kultur sputum) sebelum diberikan terapi empirik sebagaimana dalam PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa.
- f. Belum ada alur penegakan diagnosis dan alur tata laksana pneumonia dewasa dan pneumonia anak yang dapat dipahami oleh semua.
- g. *Clinical Pathway/ CP* yang ada belum diimplementasikan di semua unit. CP dan PPK belum sesuai dengan PNPK.
- h. Tingginya kasus diagnosis pneumonia dewasa (dan pneumonia anak) yang dirawat inap kurang dari 3 hari, kriteria rawat inap tidak sesuai dengan PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa. Pemantauan terhadap pasien dengan kasus lama rawat inap 1-2 hari dinilai masih kurang. Dalam CP dan PPK yang ada di RS, lama rawat kasus pneumonia adalah 7 hari.
- i. Terdapat kasus penurunan kesadaran dengan hasil rontgen pneumonia dan dilakukan rawat inap selama 11 jam lalu dirujuk dengan catatan sebagai pulang paksa.
- j. Pemberian antibiotika pada kasus pneumonia belum sesuai dengan PNPK, terapi antibiotik pada kasus pneumonia sesuai dengan PNPK adalah ceftriaxone digabung dengan macrolide/ aminoglikosida.
- k. Terdapat kasus pneumonia dewasa dengan pemberian antibiotik *intra vena* hanya 1 hari.
- l. Terdapat kasus pneumonia yang dirawat inap selama 7 jam dengan pemberian antibiotika tablet, bukan *intra vena*.

- m. Terdapat kasus pasien yang sudah perburukan (hasil EWS: 7), namun tidak masuk ICU.
- n. Hasil rontgen dikatakan (broncho)pneumonia, tetapi ketika dilihat foto basah tidak memenuhi gambaran sebagai pneumonia. Belum jelas diagnosis pneumonia tetapi didiagnosis sebagai pneumonia.
- o. Terdapat kasus pada pasien yang saat masuk didiagnosis dengan tonsilektomi, lalu dilakukan rontgen dan dinilai sebagai pneumonia, setelahnya diagnosis menjadi bronkopneumonia. Pasien dirawat selama 2 hari dan diminta kontrol. Saat kontrol penilaian kondisi utama, baik.
- p. Terdapat kasus dengan Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) Diare, lalu dilakukan rontgen dan dinilai sebagai pneumonia, setelahnya diagnosis menjadi bronkopneumonia.
- q. Terdapat kasus bronkopneumonia dengan sepsis yang dirawat inap selama 37 jam (kurang dari 2 hari) dengan catatan kondisi pulang sebagai pulang sehat.

Penegakan diagnosis pneumonia hanya melihat klinis tidak ditunjang dengan pemeriksaan lainnya sesuai ketentuan untuk memastikan diagnosis pneumonia.
- r. Belum ada prosedur konsul DPJP untuk memastikan *patient safety* seperti harus dilakukan rawat inap bersama.

2. Manajerial

- a. Belum ada Tim pencegahan kecurangan JKN di internal Rumah Sakit sehingga belum berjalannya *Plan Do Study Action* (PDSA) dalam konteks melihat potensi fraud.
- b. Standar Prosedur Operasional (SPO) pneumonia tidak sesuai dengan penulisan tata naskah, tidak ada nomor dokumen, tidak ada logo Rumah Sakit dan tidak ada tanda tangan yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Penanganan keluhan belum optimal, *google review* rating 3,5

3. Kapasitas SDM Pelaksana dan Sarana Prasarana

- a. Staf khusus untuk melakukan analisis data belum ada.
- b. Jumlah perawat untuk pelayanan rawat inap masih kurang.

- c. *Clinical Pathway* (CP) belum diimplementasikan dengan baik. Kurangnya kepatuhan terdapat pelaksanaan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP) pneumonia diantaranya lama hari rawat, pemberian antibiotik, pemeriksaan penunjang medis.
 - d. Kemampuan Audit Medis Rumah Sakit masih terbatas.
 - e. *Awareness* potensi fraud masih kurang.
4. Sistem Informasi
- a. Pada sampel rekam medis yang diperiksa saat audit medis, resume medis tidak lengkap diisi penunjang, riwayat penyakit dahulu dan tata laksana selama perawatan. Dari sampel rekam medis juga ditemukan tidak adanya tanggal masuk dan tanggal keluar pasien.
 - b. Pada sampel rekam medis, terdapat ketidaksinkronan antara rekam medis/ resume medis dengan penagihan yang diajukan.
 - c. Pada sampel rekam medis formulir asesmen awal triase tidak berkaitan dengan asesmen rawat inap di CPPT.
 - d. Informasi waktu/jam di CPPT serta nama dan tanda tangan DPJP tidak lengkap.
 - e. Adanya status pulang yang berbeda antara rekam medis dengan data pengajuan cara pulang pasien, misalnya di rekam medis tertulis meninggal namun pengajuan cara pulang tertulis sehat.

II. Rekomendasi Medis

Rekomendasi medis atas hasil pelaksanaan audit medis kasus pneumonia sebagai berikut:

1. Tata laksana pneumonia harus disesuaikan dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 dan Buku Panduan Pelayanan Neonatal UKK Neonatologi PP IDAI.
2. Diagnosis pneumonia harus berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium, dll.), dan lainnya sesuai dengan PNPK dan/atau pedoman yang berlaku. Bukti hasil pemeriksaan klinis dan penunjang harus jelas, memiliki keterhubungan yang dapat memastikan diagnosis akhir.

3. Diagnosis pasti pneumonia ditegakkan jika pada pemeriksaan radiologi ditemukan infiltrat baru atau progresif/ opasitas/ konsolidasi/ air *bronchogram* ditambah dengan awitan akut dari beberapa gejala dan tanda. Berikut merupakan gejala pneumonia:
 - a. Batuk
 - b. Nyeri dada
 - c. Sesak napas
 - d. Perubahan karakteristik sputum/ purulent
 - e. Suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (aksila)/riwayat demam
 - f. Pada pemeriksaan fisis dapat ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki.
 - g. Jumlah leukosit ≥ 10.000 sel/ μL atau < 4500 sel/ μL dengan peningkatan neutrofil batang atau *immature granulocytes*.
4. Sesuai dengan PNPk Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa, penanganan kasus pneumonia harus disertai pemeriksaan gram atau kultur bakteri untuk memastikan terapi yang tepat dalam penanganannya.
5. Pemeriksaan fisis pada neonatus, salah satunya ditandai adanya tanda-tanda gawat nafas, melalui skor Downe.

Pemeriksaan	Skor Downe		
	0	1	2
Frekuensi Nafas	<60/menit	60-80/menit	>80/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan pemberian O_2	Sianosis walaupun diberi O_2
Suara Nafas	Suara nafas di kedua paru baik	Suara nafas di kedua paru menurun	Tidak ada suara nafas di kedua paru
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu

Evaluasi:

Skor total ≤ 3 : gawat nafas ringan

Skor total 4-5: gawat nafas sedang

Skor total ≥ 6 : gawat nafas berat

Pemeriksaan penunjang pada neonatus diantaranya termasuk:

- Pemeriksaan darah lengkap
- Pemeriksaan analisis gas darah dan kultur darah, CRP (fasilitas lengkap)
- Rontgen dada: berupa infiltrat di lapang paru yang terkena
- Kultur bakteri

6. Diagnosis utama dan diagnosis sekunder harus sesuai dengan perjalanan penyakit pasien dan terapi yang dilakukan.
7. Setelah penegakan diagnosis pneumonia, dilanjutkan dengan kriteria CURB-65 atau PSI untuk menentukan indikasi rawat jalan atau rawat inap.
8. Penentuan pasien pneumonia pada dewasa dirawat jalan atau dirawat inap harus berdasarkan sistem skoring CURB-65 atau PSI.

Skor CURB-65

Confusion Uji mental $\leq$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 1 Uji mental $>$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 0
Ureum Ureum $>$ 40 mg/dL $\rightarrow$ skor 1 Ureum $\leq$ 40 mg/dL $\rightarrow$ skor 0
Respiratory Rate (RR) RR $>$ 30x/menit $\rightarrow$ skor 1 RR $\leq$ 30x/menit $\rightarrow$ skor 0
Blood pressure (BP) BP $<$ 90/60 mmHg $\rightarrow$ skor 1 BP $\geq$ 90/60 mmHg $\rightarrow$ skor 0

Umur
Umur $\geq$ 65 tahun $\rightarrow$ skor 1
Umur $<$ 65 tahun $\rightarrow$ skor 0

Penilaian berat pneumonia dengan menggunakan sistem skor CURB-65 adalah sebagai berikut:

- 1) Skor 0 – 1: risiko kematian rendah, pasien dapat berobat jalan.
- 2) Skor 2: risiko kematian sedang, dapat dipertimbangkan untuk dirawat.
- 3) Skor $\geq$ 3: risiko kematian tinggi dan dirawat harus ditata laksana sebagai pneumonia berat
- 4) Skor 4 atau 5: harus dipertimbangkan perawatan intensif

Pneumonia Severity Index (PSI)

Karakteristik Pasien	Nilai
Faktor demografik	
▪ Umur	
– Laki-Laki	Umur (tahun)
– Perempuan	Umur (tahun)-10
▪ Penghuni Panti Werda	+10
Penyakit komorbid	
▪ Keganasan	+30
▪ Penyakit hati	+20
▪ Penyakit jantung kongestif	+10
▪ Penyakit serebro vaskular	+10
▪ Penyakit ginjal	+10
Pemeriksaan fisis	
▪ Gangguan kesadaran	+20
▪ Frekuensi nafas >30 x/menit	+20
▪ Tekanan darah sistolik <90 mmHg	+20
▪ Suhu tubuh $<35^{\circ}\text{C}$ atau $>40^{\circ}\text{C}$	+15
▪ Frekuensi Nadi >125 x/menit	+10

Hasil laboratorium	
▪ PH < 7.35	+30
▪ Ureum > 64,2 mg/dL	+20
▪ Natrium < 130 mEq/L	+20
▪ Glukosa > 250 mg/dL	+10
▪ Hematokrit < 30%	+10
▪ Tekanan O2 darah arteri < 60 mmHg	+10
▪ Efusi pleura	+10

PSI digunakan untuk menetapkan indikasi rawat inap pneumonia komunitas.

- 1) Skor PSI lebih dari 70.
- 2) Bila skor PSI kurang dari 70, pasien tetap perlu dirawat inap bila dijumpai salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - i. Frekuensi napas > 30 kali/menit
 - ii. PaO₂/FiO₂ kurang dari 250 mmHg
 - iii. Radiologi menunjukkan infiltrat/ opasitas/ konsolidasi multi lobus
 - iv. Tekanan sistolik < 90 mmHg
 - v. Tekanan diastolik < 60 mmHg.
- 3) Pneumonia pada pengguna NAPZA.

Total poin yang didapatkan dari PSI dapat digunakan untuk menentukan risiko, kelas risiko, angka kematian, dan jenis perawatan

Derajat Skor Risiko PSI

Total Poin	Risiko	Kelas Risiko	Angka Kematian	Perawatan
Tidak diprediksi	Rendah	I	0.1%	Rawat jalan
≤ 70		II	0.6%	Rawat jalan

71 - 90		III	2.8%	Rawat inap/ Rawat jalan
91 - 130	Sedang	IV	8.2%	Rawat inap
> 130	Berat	V	29.2%	Rawat inap

9. Hasil Skoring CURB-65 dan PSI dilampirkan sebagai persyaratan klaim.
10. Pasien pneumonia yang dirawat, pemberian dan evaluasi antibiotik paling cepat dilakukan dalam 72 jam sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 halaman 50.
11. Pasien pneumonia yang dirawat inap diperiksa pemeriksaan mikrobiologi sputum (Kultur sputum atau gram sputum sesuai kemampuan Lab RS) sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 halaman 13-14. Hal ini diperlukan untuk mencegah *anti microbial resistance*.
12. Penulisan rekam medis harus dapat dipastikan memberikan gambaran yang jelas tentang pasien secara individu yang unik (bukan individu yang sama antara satu pasien dengan pasien lainnya), mulai dari data umum, hasil pemeriksaan awal, proses penegakan diagnosis, penegakan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang yang terhubung dengan penilaian klinis, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk resume medis dan cara pulang pasien yang dapat menggambarkan secara jelas kebenaran diagnosis yang ditegakkan.

III. Rekomendasi kepada Instansi/Pemangku Kepentingan

Rekomendasi yang disusun antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Rumah Sakit
 - a. harus memiliki Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP) untuk semua penyakit yang ditanganinya, minimal untuk 20 penyakit terbanyak yang ditangani pada saat awal bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 - b. harus melakukan reviu/ perbaikan/ penyempurnaan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP), tidak terbatas untuk

Pneumonia, agar sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) atau ketentuan yang berlaku.

- c. harus dipastikan memiliki program audit medis internal oleh Komite Medis dan Kelompok Staf Medis (KSM) terhadap kasus *high volume*, *high risk* serta meningkatkan peran dan fungsi tim anti *fraud* dan terus meningkatkan program audit medis internal.
- d. harus memastikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Dalam Perjanjian Kerja Sama, harus ditegaskan dengan jelas tidak bersifat umum.
- e. harus meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PPK dan CP melalui audit kepatuhan oleh Tim Mutu RS.
- f. harus memastikan sinergi dan koordinasi antar bagian dalam upaya memastikan mutu layanan termasuk melakukan audit medis mandiri
- g. harus memastikan kelengkapan pengisian rekam medis dan melaksanakan rekam medis elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Untuk Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi

- a. Melakukan penguatan kapasitas anggota secara periodik dan terukur dalam rangka menjaga dan memastikan mutu pelayanan kesehatan, termasuk memastikan pengisian rekam medis yang lengkap dan benar.
- b. Melakukan revidi terhadap standar pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Untuk Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ARSADA dan/atau ARSSI)

- a. Memastikan kapasitas anggotanya secara terukur dalam menjaga mutu layanan kesehatan sesuai ketentuan, termasuk memastikan pengisian resume medis yang lengkap dan benar sebagai dokumen autentik yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan.

- b. Memastikan anggotanya memenuhi sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
4. Untuk TKMKB Provinsi dan Cabang
- a. Harus aktif meminta kepada BPJS Kesehatan dalam proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap proses penjaminan mutu layanan dan memastikan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk dalam menindaklanjuti hasil-hasil audit medis baik internal maupun dari TKMKB Pusat.
 - b. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
 - c. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, Asosiasi Faskes, dll).
5. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten
- a. Memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta berjalan secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan.
 - b. Memperkuat fungsi monitoring evaluasi serta pembinaan kepada fasilitas kesehatan dalam upaya implementasi mutu layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, secara periodik dan terukur.
 - c. Menyediakan dan memastikan fasilitas pemeriksaan yang merata untuk pemeriksaan mikrobiologi/ kultur.
6. Untuk BPJS Kesehatan Wilayah dan Cabang
- a. Harus dapat memastikan proses kredensialing dan/atau proses re-kredensialing mendapatkan fasilitas kesehatan yang dapat

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu dan layanan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, termasuk dipastikan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan tanpa pemberian rujukan ke fasilitas kesehatan lain.

- b. Menyampaikan rekomendasi TKMKB kepada manajemen RS dan memastikan terlaksananya rekomendasi tersebut dengan memastikan diketahui oleh komite medik.
- c. BPJS Kesehatan Wilayah bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang melakukan evaluasi bersama TKMKB Provinsi dan TKMKB Cabang dan/atau pemangku kepentingan lainnya pada kesempatan pertama setelah rekomendasi ini diterima dan melaporkan hasilnya kepada BPJS Kesehatan Pusat melalui Kedeputian Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat.
- d. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
- e. Komunikasi intensif perlu dibangun melalui rapat koordinasi berbasis data sehingga tercipta *early warning system* yang dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sekali melalui *utilization review* bersama dengan Rumah Sakit, TKMKB dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan.
- f. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, Asosiasi Faskes, dll).
- g. Memastikan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada fasilitas kesehatan berjalan efektif dan terukur.